

Sindromi Affettive e Sindromi Ansiose

Salute Mentale · Sessione 06 · 25.03.2026

Questa lezione entra nel cuore della psicopatologia dell'umore e dell'ansia: capisci cosa distingue la tristezza "normale" dalla depressione, come funziona il pendolo timico nei disturbi bipolari, e perché l'ansia — quando è sana — ti aiuta, mentre quando diventa cronica ti paralizza. Roba che incontrerai nella pratica professionale ogni giorno.

Le emozioni: punto di partenza

Prima di parlare di sindromi, bisogna capire cosa sono le emozioni. Il termine viene dal latino *ex-movere* — letteralmente "muovere fuori". **Galimberti (1999)** le definisce come «una reazione affettiva intensa con insorgenza acuta e di breve durata determinata da uno stimolo ambientale». **Plutchik (2017)** aggiunge che si tratta di «un discostarsi fisiologico dall'omeostasi», percepito soggettivamente come sentimento intenso e accompagnato da cambiamenti corporei (battito, respiro, tensione muscolare, ecc.).

Le emozioni hanno due funzioni principali: - **Adattamento:** ci permettono di riconoscere pericoli e rispondervi - **Comunicazione:** esprimono all'altro come stiamo, creano relazione

Importante: le emozioni non sono né positive né negative in sé. La rabbia, la tristezza, la paura — tutte hanno uno scopo. Diventano un problema solo quando sono così intense o durature da interferire con la vita quotidiana.

Emozioni di base (Ekman e Friesen, 1971)

Ekman e Friesen identificano sei emozioni considerate universali come *tema*, anche se la loro *espressione* varia con la cultura e la persona: **gioia, tristezza, paura, disgusto, rabbia, sorpresa.**

Esempio dalla prof: le *prefiche* nell'antica Grecia erano donne pagate per piangere ai funerali. L'emozione (tristezza, lutto) è universale; la forma con cui viene espressa è culturale. Tienilo a mente quando lavori con persone di background diversi.

Luminet e Grynberg (2021) invitano a non escludere né la prospettiva universale né quella culturale: dipende dalla situazione quale sia preponderante.

Il modello multidimensionale di Plutchik (2017)

Plutchik propone otto emozioni di base (non sei come Ekman), disposte in un **modello a fiore** con tre dimensioni chiave:

1. **Intensità:** verso il centro del fiore l'emozione si intensifica (*tristezza* → *angoscia*; *gioia* → *estasi*; *rabbia* → *collera*). Verso l'estremità si attenua (*tristezza* → *pensierosità*; *rabbia* → *irritazione*).
2. **Emozioni secondarie:** nascono dalla combinazione di due emozioni primarie (*sorpresa* + *tristezza* = *disapprovazione*; *rabbia* + *disgusto* = *disprezzo*).
3. **Opposti:** ogni emozione ha la sua emozione contraria nel fiore.

Perché è utile? Perché permette di leggere la complessità dell'esperienza emotiva dei pazienti in modo più sfumato rispetto a un semplice elenco.

Emozione vs. Umore

- **Emozione:** reazione intensa, acuta, breve, sempre generata da un evento stimolo specifico
- **Umore (Delay, 1946):** «disposizione affettiva di fondo [...] che dà a ciascuno stato d'animo una tonalità gradevole o sgradevole, oscillante fra i due poli estremi del piacere e del dolore» — è più persistente, non richiede un evento scatenante preciso

Metafora dalla prof: l'umore è la luce ambiente di una stanza (oggi mi sento bene, o grigio). L'emozione è quando si apre la porta: entra qualcuno, mi spaventa o mi sorprende — reazione immediata.

Le depressioni

Fin qui ci siamo? Bene. Adesso entriamo nel territorio della clinica vera.

La tristezza non è patologica. Provare tristezza è normale, funzionale, necessaria. Ci permette di elaborare perdite, riconoscere errori, avvicinarci al nostro dolore. La **depressione**, invece, è uno stato psicopatologico che *inibisce le risposte emotive* e limita l'adattamento della persona all'ambiente.

Nota: anche qui non si parla di "la depressione" ma di "le depressioni" — perché ne esistono diverse forme con cause e trattamenti differenti.

Il nucleo semiologico comune (Melanie Klein)

Tutte le forme depressive condividono un nucleo comune:

- **Umore depresso:** abbassamento del tono timico (il "pendolo timico" è spostato verso il polo della tristezza)
- **Sindrome da rallentamento psicomotorio:** lentezza nei gesti, nell'andatura, nella voce, nell'elaborazione cognitiva
- **Anedonia depressiva:** incapacità di provare piacere per attività che prima lo suscitavano — è il *sintomo* soggettivo
- **Rallentamento psichico:** tutti i processi cognitivi (attenzione, percezione, memoria) risultano rallentati
- **Apatia** (spesso coesistente): assenza di motivazione — **diversa dall'anedonia, che è assenza di piacere**

Suggerimento della prof: quando incontri parole con il prefisso "a-" (anedonia, apatia, abulia...) ricorda che in greco l'alfa privativo significa che "quella cosa non c'è". Utile per memorizzare tutto il vocabolario medico-psicologico.

Classificazione didattica: Lalli (2002)

Nicola Lalli propone due grandi categorie:

Depressioni primarie — tutte originate dal *carattere depressivo*, ovvero un pattern psicologico caratterizzato da: - bassa autostima - dipendenza da figure idealizzate - ambivalenza amore-odio verso l'altro - rabbia repressa per paura dell'abbandono

Tipo	Caratteristica
Depressione reattiva	Causa comprensibile: lutto, trauma, perdita
Depressione nevrotica (distimia)	Ferita narcisistica; persona reattiva all'ambiente
Depressione maggiore	Forma grave con episodi distinti
Depressione mascherata	Il malessere psicologico si manifesta con sintomi somatici
Depressione esistenziale	Legata ai conflitti evolutivi di Erikson (es. integrazione vs. disperazione)

Depressioni secondarie — sempre di origine organica: - Secondaria a malattie somatiche (**diabete, ipotiroidismo, tumori, malattie cardiovascolari, autoimmuni**) - Secondaria a disturbi neurologici (**Parkinson, ecc.**) - Secondaria a farmaci (**es. alcuni beta-bloccanti**) - Fase depressiva del disturbo bipolare

La prof sottolinea: il fatto che una depressione sia secondaria a una malattia organica non significa che non vada trattata anche psicologicamente. Curare l'umore migliora anche la compliance terapeutica.

I tre gruppi clinici principali

Gruppo	Caratteristica chiave	Atteggiamento del paziente
Depressioni psicogene	Causa comprensibile	Si sente vittima ; reattività all'ambiente conservata

Gruppo	Caratteristica chiave	Atteggiamento del paziente
Depressioni endogene/ melanconiche	Causa non identificabile	Si sente colpevole ; perdita di reattività; anamnesi familiare spesso positiva
Depressioni di origine somatica	Origine organica	Cfr. secondarie

Caso clinico: il piccolo Jean (cartella clinica anni '70, Reggio Emilia) **Bambino di 6 anni allontanato traumaticamente dalla famiglia. In atelier di pittura i colori evolvono da rosso acceso a nero totale nei giorni di peggioramento, poi tornano con il miglioramento clinico. Esempio di depressione reattiva con reattività all'ambiente conservata — la stimolazione funzionava.**

Nota importante: questo tipo di lettura dei colori è valida solo in relazione alla cartella clinica complessiva. Non si interpreta un colore isolatamente.

Disturbo depressivo maggiore e disturbo depressivo persistente (DSM-5-TR)

Disturbo depressivo maggiore: - Episodi distinti di **≥ 2 settimane** con nette modificazioni affettive, cognitive e neurovegetative - Possibili remissioni interepisodiche (ritorno all'eutimia, poi nuovo episodio) - Se c'è stato un primo episodio, nella maggioranza dei casi ci saranno recidive - **Attenzione:** quando il paziente torna all'eutimia non deve interrompere la terapia da solo — il secondo episodio risponde meno al farmaco

Disturbo depressivo persistente: - Abbassamento cronico dell'umore per **≥ 2 anni** negli adulti (**1 anno** nei bambini) - Depressione meno marcata del disturbo maggiore, ma senza ritorno all'eutimia - Include le vecchie categorie DSM-IV "Depressione maggiore cronica" e "Distimia"

Depressione mascherata: la sofferenza depressiva si esprime esclusivamente attraverso sintomi somatici (dolori, malesseri fisici). La persona non riconosce il proprio stato come depressione. **Da non confondere con l'ipocondria:** alla base di

quella c'è ansia per la propria salute — quindi appartiene alle sindromi ansiose, non affettive.

I disturbi bipolari

I disturbi bipolari erano chiamati in passato *maniaco-depressivi*. **Caratteristica principale:** passaggio repentino da umore profondamente deflesso al polo opposto.

Breve storia del concetto: - **Areteo di Cappadocia**: primo a descrivere sistematicamente il legame tra melanconia e mania - **Falret (1851)**: "follia circolare" - **Kraepelin (XIX sec.)**: distinse psicosi maniaco-depressiva dalla demenza precoce - **Leonhard (1957)**: introdusse il concetto di "depressione bipolare"

Il pendolo timico

Immagina un pendolo. Al centro c'è l'**eutimia** — l'umore in equilibrio. A sinistra c'è la depressione, a destra la mania. Nei disturbi bipolari, il pendolo oscilla tra i due estremi in modo patologico e repentino. Questo è il *pendolo timico*.

Episodio maniacale: cosa si vede

- Euforia eccessiva e prolungata
- **Insonnia senza stanchezza** (iperattività fa bruciare le calorie → calo di peso nonostante appetito aumentato)
- Agitazione psicomotoria, logorrea
- Accelerazione dei processi psichici → **fuga di idee** (passa da un argomento all'altro senza legame)
- Autostima ipertrofica, possibili **deliri di grandezza**
- Dispendio di denaro, impegno in progetti senza competenze
- Disinibizione sociale e sessuale
- Reattività aggressiva
- **Perdita di contatto con la realtà** — non è solo "umore alto", è uno scompenso

Esempio della prof: un paziente in fase maniacale entrava nei bar e offriva da bere a tutti; comprava scarpe costose agli amici. La prof lo sentiva arrivare dal corridoio già mentre era in fondo al corridoio.

Episodio depressivo nel bipolare

Simile al disturbo depressivo maggiore, ma: - In anamnesi ci sono episodi ipomaniacali/maniacali precedenti - **Attenzione terapeutica cruciale:** somministrare un antidepressivo a un paziente bipolare in fase depressiva rischia di spostare il pendolo verso la mania → la terapia standard sono gli **stabilizzatori dell'umore** (sali di litio o anticonvulsivi)

I tipi di disturbo bipolare

Tipo	Oscillazione
Bipolare I	Episodi depressivi ↔ episodi maniacali (completi)
Bipolare II	Episodi depressivi ↔ episodi <i>ipomaniacali</i> (meno intensi)
Disturbo ciclotimico	Fluttuazione continua per ≥ 2 anni senza raggiungere mai i criteri pieni di nessuna delle due fasi

Il bipolare II non è "più lieve" del I — la sofferenza c'è. Il ciclotimico, in passato considerato meno grave, oggi sappiamo che non lo è.

Aspetti pratici per l'operatore sociale

- Il paziente spesso interrompe la terapia quando si sente bene → rischio recidiva
 - Il **litio** va monitorato con esami del sangue regolari (tossico se supera il dosaggio massimo)
 - I **familiari** sono una risorsa cruciale per riconoscere i segnali precoci di cambiamento d'umore — psicoeducazione ai familiari è parte del trattamento
-

Le sindromi ansiose

Cambio di prospettiva: ora parliamo della paura e dell'ansia.

Paura vs. Ansia: la distinzione fondamentale

	Paura	Ansia
Stimolo	Pericolo concreto, presente, identificabile	Minaccia indefinita, futura, ipotetica
Carattere	Episodico	Vigilanza sostenuta
Risposta	Emergenza (lotta/fuga)	Ipervigilanza, evitamento
Funzione	Sopravvivenza immediata	Preparazione anticipatoria

Esempio della prof: c'è un cane che ringhia davanti a me → **paura**. Non vado a passeggiare al lago perché *temo* che potrebbe esserci un cane senza guinzaglio → **ansia**. E l'ansioso aggiunge: "sicuramente è lì, sicuramente è aggressivo, sicuramente identifica proprio me..."

Anche l'ansia è normale e funzionale: una dose prima di un esame aumenta le prestazioni. Diventa patologica quando è **sproporzionata nell'intensità o nella durata** e interferisce con la vita quotidiana.

Il rimuginio ansioso

Il **rimuginio** (Borkovec et al., 1998, citati in Caselli et al., 2017) è «una strategia di regolazione delle preoccupazioni che implica la costruzione mentale ripetuta di ipotetici scenari futuri negativi in condizione di incertezza». È la caratteristica principale del **disturbo d'ansia generalizzato (DAG)**.

Il **paradosso**: più la persona rumina per abbassare l'ansia, più genera nuovi scenari negativi, più l'ansia si alimenta. Se cronico, porta conseguenze fisiche: tensione muscolare, disturbi del sonno, dolori cronici.

Da distinguere dalla **ruminazione depressiva**, che è orientata al passato (cause di eventi già accaduti, svalutazione di sé).

	Rimuginio ansioso	Ruminazione depressiva
Orientamento	Futuro	Passato
Temi	Anticipazione minacce	Perdita, significato, rappresentazione di sé
Funzione	Prepararsi alla minaccia	Comprendere cause e significati

Sintomi dell'ansia: i quattro livelli

Cognitivo: - Ipervigilanza e monitoraggio continuo dell'ambiente - Difficoltà di concentrazione, forte distraibilità - Paura di perdere il controllo o di morire - Perdita di obiettività

Affettivo: - Paura che l'evento temuto si realizzi - Irritabilità e suscettibilità - Inquietudine, impazienza - Sensazione di oppressione (spesso proiettata anche sul torace — difficoltà respiratorie soggettive)

Fisiologico: - Aumento del battito cardiaco - Respiro accelerato → iperventilazione - Tremori, brividi, secchezza delle fauci - Vertigini, nausea, tensione muscolare

Comportamentale: - Agitazione, irrequietezza - **Evitamento** delle situazioni temute (efficace a breve termine, **controproducente a lungo**) - **Ricerca compulsiva di rassicurazione (web, AI) → paradossalmente alimenta l'ansia, porta alla "diagnosi peggiore possibile"**

Disturbi d'ansia (DSM-5-TR)

Disturbo	Caratteristica principale
Disturbo d'ansia generalizzato (DAG)	Ansia su molti ambiti; rimuginio come elemento centrale

Disturbo	Caratteristica principale
Disturbo d'ansia sociale	Timore del giudizio negativo; evitamento situazioni sociali; emozione centrale = vergogna
Disturbo di panico	Attacchi ricorrenti e inaspettati; ≥ 4 sintomi fisici/cognitivi; durata: pochi minuti
Agorafobia	Evitamento situazioni in cui la fuga è difficile
Fobia specifica	Paura irrazionale di un oggetto/situazione
Disturbo d'ansia da separazione	Paura eccessiva della separazione da figure di attaccamento
Mutismo selettivo	Incapacità di parlare in certi contesti sociali

Nota: nel DSM-5-TR il DOC (disturbo ossessivo-compulsivo) e il PTSD (disturbo post-traumatico da stress) **non** rientrano più tra i disturbi d'ansia — hanno capitoli propri.

L'attacco di panico

Durante un **attacco di panico** la persona vive una paura intensissima con sintomi fisici marcati, sensazione di perdita totale di controllo e convinzione di stare per morire. Il picco si raggiunge in pochi minuti.

La prof precisa: dall'attacco di panico in sé non si muore. Ma la persona è convinta del contrario — e la risposta comportamentale impulsiva può creare situazioni di rischio. L'accoglienza senza giudizio è il nostro strumento principale.

Il dolore psichico e il corpo

Riflessione finale della prof, importante per l'operatore sociale: quando il dolore psichico diventa insopportabile, alcuni pazienti usano il **dolore fisico** per sospenderlo temporaneamente (autolesionismo). Non è razionale — è una risposta di emergenza. Riconoscerlo senza giudicarlo è parte del nostro lavoro.

«Non c'è sempre un cerotto da mettere sul corpo — ma questo non vuol dire che la persona non stia male.» La sofferenza invisibile è ancora sofferenza. Tienitelo a mente quando lavori con pazienti i cui esami del sangue sono "tutti a posto".

Domande di orientamento allo studio

Qual è la differenza tra tristezza normale e depressione clinica? Perché è importante non confonderle?

La tristezza è un'emozione normale, funzionale e necessaria: permette di elaborare perdite, riconoscere errori, avvicinarsi al dolore. La depressione clinica è invece uno stato psicopatologico che inibisce le risposte emotive e limita la capacità di adattamento della persona all'ambiente. Il nucleo semiologico comune alle forme depressive include umore depresso (pendolo timico spostato verso il basso), sindrome da rallentamento psicomotorio, anedonia (incapacità di provare piacere), rallentamento psichico e spesso apatia. Non confonderle è importante perché trattare la tristezza come patologia rischia di medicalizzare una risposta normale, mentre non riconoscere la depressione lascia la persona senza supporto in un momento in cui ne ha bisogno.

Descrivi il pendolo timico nel disturbo bipolare. Perché somministrare un antidepressivo durante una fase depressiva bipolare può essere pericoloso?

Il pendolo timico è la metafora dell'oscillazione dell'umore: al centro c'è l'eutimia (umore in equilibrio), a sinistra la depressione, a destra la mania. Nel disturbo bipolare il pendolo oscilla tra i due poli in modo patologico e repentino. Somministrare un antidepressivo durante una fase depressiva bipolare è pericoloso perché può spostare il pendolo verso il polo maniacale, scatenando un episodio maniacale invece di stabilizzare il tono dell'umore. La terapia corretta per il disturbo bipolare sono gli stabilizzatori dell'umore (sali di litio o anticonvulsivi), non gli antidepressivi.

Cosa caratterizza un episodio maniacale? Quali segnali precoci possono riconoscere i familiari?

L'episodio maniacale si caratterizza per: euforia eccessiva e prolungata, insonnia senza stanchezza, agitazione psicomotoria e logorrea, accelerazione dei processi psichici con fuga di idee, autostima ipertrofica e possibili deliri di grandezza, comportamenti disinibiti (spendere denaro, impegnarsi in progetti senza competenze, disinibizione sessuale), reattività aggressiva e progressiva perdita di contatto con la realtà. I segnali precoci che i familiari possono riconoscere includono il diminuito bisogno di sonno senza stanchezza, il cambiamento nel ritmo del parlare, l'irritabilità fuori contesto e il dispendio di denaro inusuale. La psicoeducazione ai familiari è parte integrante del trattamento.

Qual è la differenza tra rimuginio ansioso e ruminazione depressiva? Come aiuta distinguerli nella pratica?

Il rimuginio ansioso è orientato al futuro: costruisce ripetutamente scenari negativi ipotetici in condizione di incertezza. La funzione è quella di prepararsi a una minaccia anticipata, ma il paradosso è che più si rumina per abbassare l'ansia, più si generano nuovi scenari negativi. La ruminazione depressiva è invece orientata al passato: torna ripetutamente sulle cause di eventi già accaduti, sulla perdita e sulla svalutazione di sé. Distinguerli aiuta nella pratica perché indicano dinamiche diverse: il rimuginante va aiutato ad abitare il presente e a tollerare l'incertezza; il ruminante va aiutato a riattivare risorse e a costruire una narrativa di sé più articolata.

Cosa è l'attacco di panico? Come risponde un operatore sociale?

L'attacco di panico è un episodio di paura intensissima con sintomi fisici marcati (aumento del battito, iperventilazione, tremori, vertigini, nausea) e sensazione di perdita totale di controllo, con convinzione di stare per morire. Il picco si raggiunge in pochi minuti. La persona non muore dall'attacco di panico in sé, ma è convinta del contrario — e le risposte impulsive possono creare situazioni di rischio.

L'operatore sociale risponde con accoglienza senza giudizio, presenza calma e non caotica, spiegazione chiara di cosa sta succedendo. Non minimizzare, non agitarsi insieme alla persona. La validazione dell'esperienza emotiva è il punto di partenza.

Concetti chiave

Termine	Significato
Emozione	Reazione affettiva acuta e breve, generata da un evento stimolo
Umore	Disposizione affettiva di fondo, persistente, oscillante tra piacere e dolore
Eutimia	Umore in equilibrio (il centro del pendolo timico)
Anedonia	Incapacità di provare piacere per attività che prima lo suscitavano (sintomo)
Apatia	Mancanza di motivazione; diversa dall'anedonia
Alfa privativo	Prefisso che indica l'assenza di qualcosa (a-nedonia = senza piacere)
Pendolo timico	Metafora dell'oscillazione dell'umore tra depressione e mania
Carattere depressivo	Pattern di base: bassa autostima, dipendenza, ambivalenza, rabbia repressa
Depressione mascherata	Depressione che si manifesta solo con sintomi somatici
Rimuginio ansioso	Costruzione ripetuta di scenari negativi futuri in condizione di incertezza
Ruminazione depressiva	Riflessione ripetitiva su cause e conseguenze di eventi negativi passati
Ipomania	Forma attenuata della mania (caratteristica del bipolare II)
Disturbo ciclotimico	Fluttuazione continua dell'umore per ≥ 2 anni senza criteri pieni

Termine	Significato
Logorrea	Parlare eccessivo e pressante, tipico della fase maniacale
Fuga di idee	Accelerazione del pensiero con associazioni rapide e scarsamente collegate
Ansia di stato	Reazione episodica a una situazione specifica
Ansia di tratto	Modalità stabile di affrontare la quotidianità con ansia costante

Collegamenti

- **Lezione 05 (Semiologia del comportamento e SMA):** tutti gli elementi semiologici (rallentamento psicomotorio, logorrea, espressione monotona, percezione alterata...) si applicano concretamente qui. La prof ha chiesto esplicitamente di fare questo collegamento.
- **Lezione 07 (Nevrosi — Perucchi-Campopiano):** approfondimento delle forme nevrotiche.
- **Seminario sul corpo (Elisa Milani):** alimentazione, peso e dimensione psicosomatica.
- **Manuali di riferimento:** [DSM-5-TR \(APA, 2023\)](#) e [ICD-11 \(OMS, 2025, edizione italiana\)](#) — per l'esame è richiesta la conoscenza delle categorie, non dei criteri diagnostici dettagliati.
- **Temi aperti:** depressione post partum vs. psicosi post partum; disturbi d'ansia in adolescenza; DOC e PTSD (capitoli separati nel DSM-5-TR).